

【咳嗽案】打败老中医系列，细菌性感冒就用清热药？中医西化后可怕

原创 二羊 养阳医斋 2021年6月19日 12:25

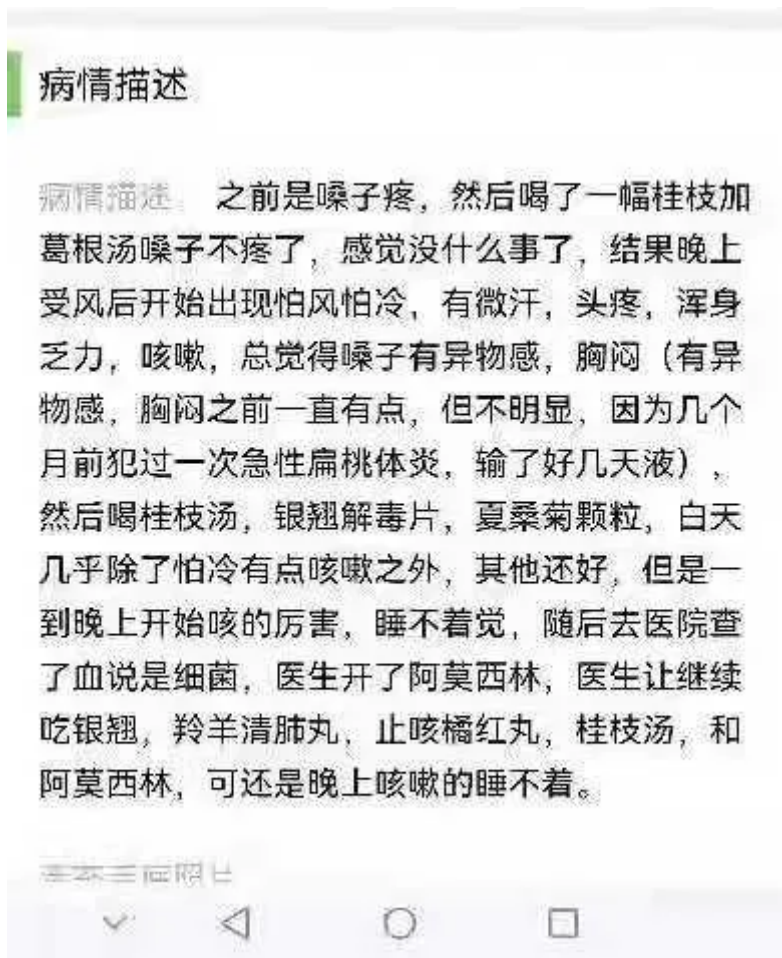
好久没写文字总结了，总有错别字，为了减少错误发生。大家心情舒坦。

今天写一个细菌性感冒的案例。为啥写这篇总结呢，因为这类情况在门诊非常多见，说不定你就是受害者之一。

先来看案例，道理留在后面说。

以为微信好友求助，她家人因为感冒咳嗽，吃了各种药还是咳嗽，夜间不能睡觉，北京最有名的中医院看了也不好使，这不把大致情况发给我。

如图：



我简单梳理一下：

- 1、开始嗓子疼，服用桂枝加葛根汤，好转。经方用的靠谱
- 2、又受风加重，怕风怕冷，微汗出，统统身体疼痛，咳嗽，胸闷。（这就不就是典型的桂枝加厚朴杏仁汤）

结果吃桂枝汤，银翘解毒片，桑菊饮颗粒--桂枝汤无所谓，后两种坏事了。

- 3、咳嗽加重，夜间不能睡，去医院看提示细菌性的。

血细胞分析+CRP

中国中医科学院广安门医院检验报告单

Guang An Men Hospital Affiliated China Academy of Chinese Medical Sciences

姓名: [REDACTED]

性别: [REDACTED]

年龄: 43岁

病人类型: [REDACTED]

ID [REDACTED]

科 室: [REDACTED]

床 号: [REDACTED]

样 本 号: 38

诊 断: 感冒;表寒里热证

条 码 号: 2106130473

标本状态: 标本合格

标本类型: 指血

1006-0711-D-JYBG

序号	项 目 名 称	代号	结果	参考值范围	单位	序号	项 目 名 称	代号	结果	参考值区间	单位
1	白细胞	*WBC	12.13	↑ 3.5—9.5	10 ⁹ /L	17	嗜酸性粒细胞数量	EO#	0.24	0.02—0.52	10 ⁹ /L
2	红细胞	*RBC	5.06	4.3—5.8	10 ¹² /L	18	嗜碱性粒细胞数量	BASO#	0.04	0—0.06	10 ⁹ /L
3	血红蛋白	*HGB	155.0	130—175	g/L	19	红细胞分布宽度SD	RDW-SD	38.9	37—50	fL
4	红细胞压积	*HCT	44.3	40—50	%	20	红细胞分布宽度CV	RDW-CV	11.9	11.6—14.6	%
5	红细胞平均体积	MCV	87.5	82—100	fL	21	血小板分布宽度	PDW	8.9	↓ 9—17	fL
6	平均血红蛋白含量	MCH	30.6	27—34	pg	22	平均血小板体积	MPV	8.8	↓ 9—13	fL
7	平均血红蛋白浓度	MCHC	350.0	316—354	g/L	23	大型血小板比率	P-LCR	15.0	13—43	%
8	血小板	*PLT	258.0	125—350	10 ⁹ /L	24	血小板比容	PCT	0.23	0.1—0.5	%
9	淋巴细胞比率	LYMPH%	29.9	20—50	%	25	C反应蛋白	CRP	24.00	↑ 0—10	mg/L
10	单核细胞比率	MONO%	7.3	3—10	%						
11	中性粒细胞比率	NEUT%	60.5	40—75	%						
12	嗜酸性粒细胞比率	EO%	2.0	0.4—8	%						
13	嗜碱性粒细胞比率	BASO%	0.3	0—1	%						
14	淋巴细胞数量	LYMPH#	3.63	↑ 1.1—3.2	10 ⁹ /L						
15	单核细胞数量	MONO#	0.88	↑ 0.1—0.6	10 ⁹ /L						
16	中性粒细胞数量	NEUT#	7.34	↑ 1.8—6.3	10 ⁹ /L						

白细胞，中性粒细胞升高，这是典型的细菌性引起。抗生素消炎药加阿莫西林走起没毛病。

如果只是淋巴细胞升高，多见于病毒性，抗生素很多人依然走起，美其名曰预防，其实是滥用。

4、神奇的操纵来了，继续吃银翘解毒片，羚羊清肺丸，这个是细菌性的，西医逻辑用消炎药有理有据，但是这一堆清热解毒的中成药算什么鬼？

理由呢？就因为是细菌性的就用这个

银翘解毒片，羚羊清肺丸，这些寒凉清里热的药，好家伙当阳明里热证、当肺炎高峰期用了。没有热却用了那么重的寒凉药你说咳嗽加重不？

5、咳嗽加重并不是因为是因为有细菌性就加重。

二羊在网上把不到脉，只能看舌头了。

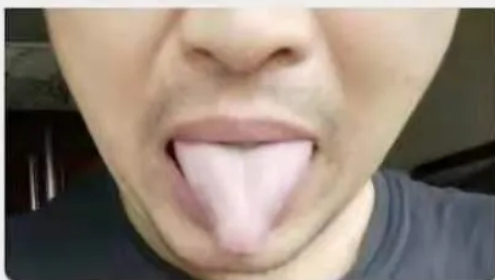


舌淡舌苔白厚腻。

哪里有热，半点热我是看不到，反而是寒湿很重。

既然是寒，咱们就用热药，不用担心太热了，即便有那不是还有消炎药，那么多清热药备着嘛。

二羊就上了方子，简单直接粗暴，也懒得多问了。



周一 10:13

吃的药太杂了



我开个方吧



法半夏 15 厚朴 15 紫苏叶 10(后下)
茯苓 15 炙甘草 6 杏仁 9 桂枝 15 白
芍 15 干姜 10 大枣 12 细辛 5



嗯嗯，太谢谢了，身边实在是没有
个好大夫🙏



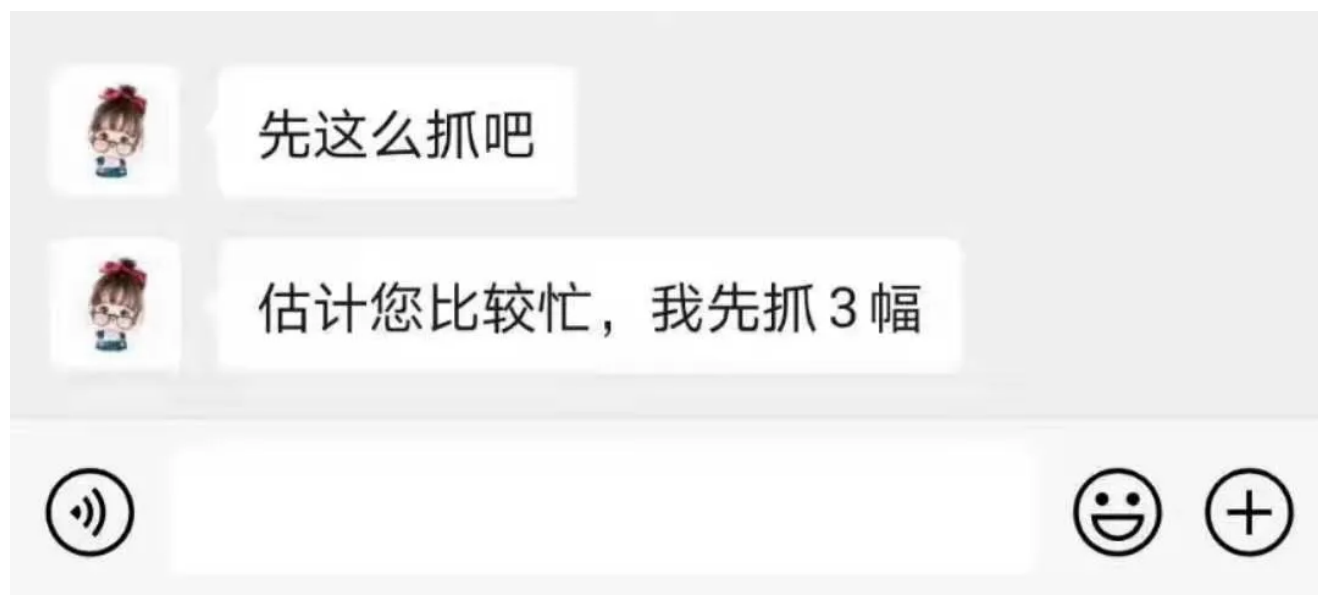
吃几副呢？还需要吃别的吗？

周一 10:31



刚去抓药说最后一味细辛最多只能
给 3 克🤔

周一 10:40



结果还是让人欣慰，至少咱们帮助病患解决了痛苦。



还有昨天您开的那个方子很有效，
当晚睡觉就不怎么咳嗽了 😊

昨天 下午1:17



🔊 18"

大夫您好，昨天然后给您发微信，
您没回我，然后我又挺着急，我又
给他买了点儿，就是您原来那个方
子接着喝了两天了吧，昨天买的应
该是好多了，我觉得应该就不用换
了，就再喝一副，我觉得应该就好
利索了。

昨天 下午3:05

好的 🤝



好了，这个案例结束了。但道理还没结束，很多喜欢好学的朋友跑来问，为什么开这个方。

熟悉伤寒论和经方或者跟过二羊学两年的基本可以猜到这个样的套路。

看部分学员给的答案



73% 11:28



中医二羊蜜友群 (2021) (92)

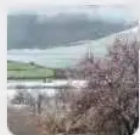


周四 23:42



还是有太阳病，桂枝汤加葛根半夏，或者小青龙汤吧。

昨天 上午7:36



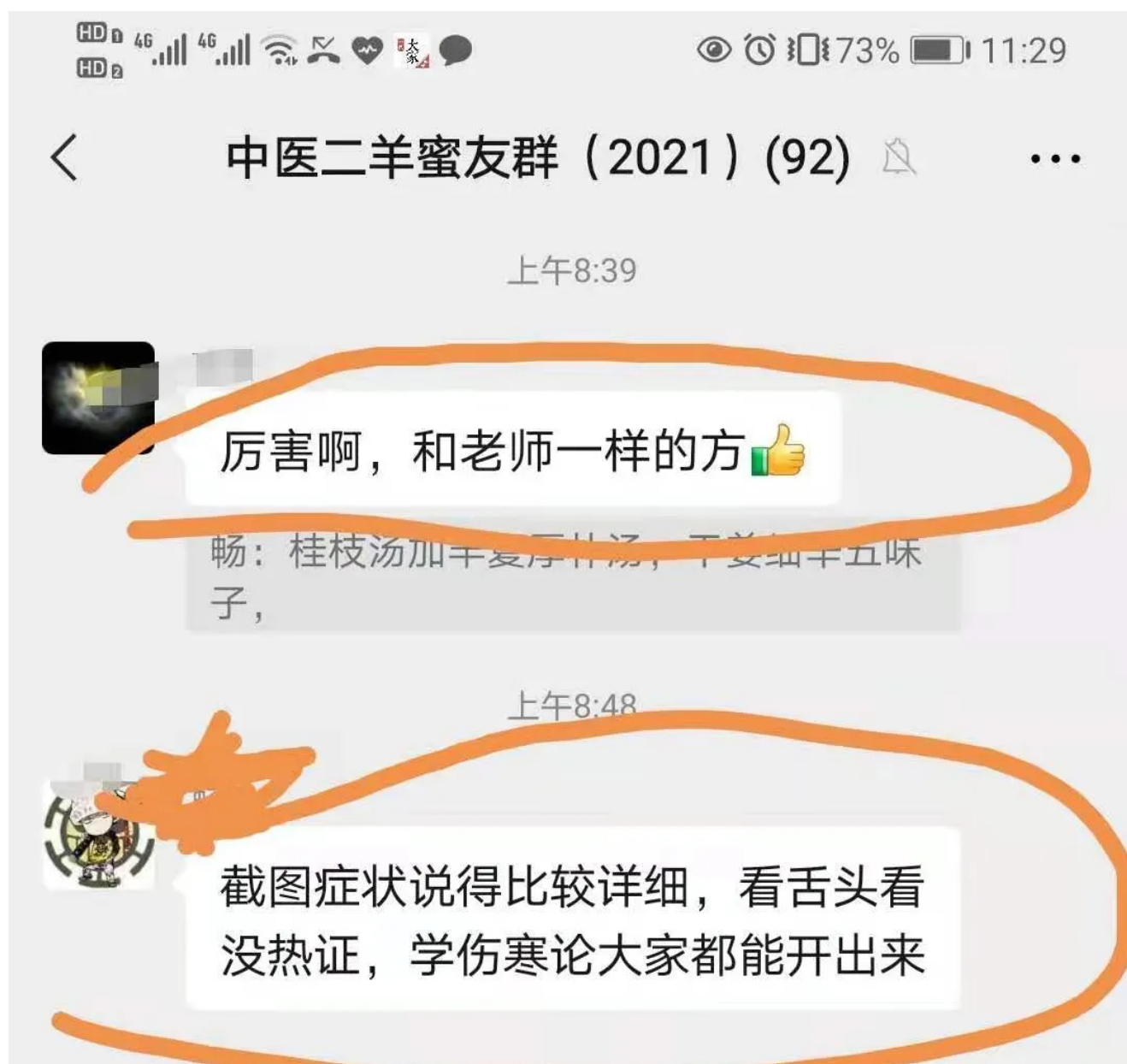
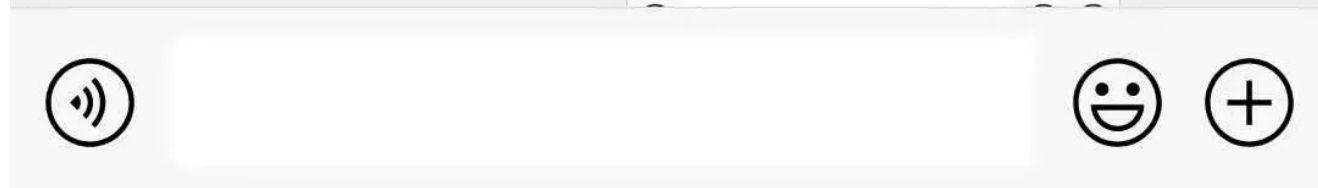
晚上怎么个咳法没有说，要看一下晚上咳的状态才好判断。这咳嗽我推断是一开始就治错了，这个人一来就是少阴病了，结果又解表又搞一堆寒凉的东西下去.....

昨天 上午7:18



畅

桂枝汤加半夏厚朴汤，干姜细辛五味子，





好了既然大家那么好学，我就简单讲讲我的思路。

就两点：

- 1、外寒的表证没有清除，汗出咳嗽胸闷，桂枝加厚朴杏仁汤。
 - 2、咽喉异物感，胸闷，结合舌苔痰湿重偏寒，半夏厚朴汤加干姜细辛
- 有人问为什么不用小青龙汤。其实用用也无妨，只是麻黄需要斟酌。

两个原因：

- 1、本能第一直觉，我不用，没有理由，因为我觉得不是
 - 2、从一开始就是桂枝汤的底子加痰湿
- 再具体的理由，就是伤寒论原文的那些。

太阳中风，汗出恶风。

咽中有炙脔（烤肉）

正文结束，下面是吐槽水文。

吐槽一：

门诊我遇到太多慢性咳嗽，就是因为感冒得不到有效正确的治疗，遗留咳嗽。

这个咳嗽得不到正确治疗呢就是慢性疑难杂病。

用经方几副药吃好了，好学又不是什么病。

总的来说，大多都是因为**有寒，表寒，水饮，痰湿多见**。这些古代病，今人会治的不多。吊水会加重！

我也不担心那些热咳，严重很重的，西医消炎药，中医清热药，大把入用甚至滥用。

那剩下的就是按他们的套路搞不好的，基本就是我讲的这几种情况。

慢性咳嗽的主要原因：**形寒饮冷则伤肺**，

这算是现代人的生活常态，吹空调形寒。各种冰冻饮料酸奶水果等。这也是慢性哮喘，鼻炎最常见的类型。

针对这种情况，小青龙汤的思路是最恰当的，只是临床复杂多变，不能简单套用，尤其是单凭某一个症状就来套用。

吐槽二：

伤寒论经方临床最好用的两种思路。

1、方证对应，有是证用适方。

2、根据病机灵活应用，适合老手。病机要点：虚实寒热表里阴阳八纲辨证为基础，结合脏腑经络气血津液以及病理产物痰湿水饮、瘀血。

但现实很多讲课培训为主的，喜欢套上易经、五运六气、术数等来解释伤寒论，解读经方。

其实伤寒论的精髓在于你去用，而不是自己设想各种理论来解释。张仲景不需要你解释，你解释的也不是人家原来的东西。

看原文就能体会仲景本意。所以，想学习伤寒论经方的朋友，奉劝你们远离那些培训中医，太玄幻的东西。

原文真的很香，医圣张仲景亲传。

吐槽三、自学中医的朋友在自己身上实验的时候，别乱来。

最近门诊遇到好几个这样的中医粉，大多都是见风便是雨，抓住一两个症状让自己嗨半天，结果把身体搞坏了。

学中医的很多人都有一个通病，先给自己一个假设，然后为了验证自己是对的，就各种折腾。例如：很多人假设自己是某种虚。杨医生，我有阳虚所以你看我有怕冷，你看还有头痛。大姨妈不好是不是也是因为这个阳虚？

兄弟搞反喽！

中医辨证是收集你的各种症状，舌脉，最后才来总结你是什么问题。而不是假设自己有这个问题才出现各种症状。

再如：杨医生我是不是因为湿气很重，睡觉不好，还长痘，是不是又阴虚啊？

。。。。杨医生有点不想理人了。

看病我就不喜欢假设，脑袋一片空白，心里一面明镜，你来看是啥就是啥？也懒得去推演，也懒得去纠结，更懒得去假设。

心里的照妖镜，静静的观察，等着疾病现出原形。

部分网友喜欢解释原理，我的身体为啥这样？你为何用这个方这个药等？

二羊的态度：先看病，看有效了我再慢慢来跟你掰扯。如果没效果掰扯啥都是无用。

好了，口水多过茶，中午大家先吃饭。

门诊时间

我目前门诊是“大中医”的状态，中医内科门诊同时兼顾针灸等传统疗法治疗，中医在我这不分科。

中药和针并用，灸、刮痧拔罐放血等根据病情来选用。

中医二羊

线下看诊流程



🕒 门诊时间
周一-周五全天、周六上午
上午 8:00-12:00 下午 14:30-17:00

📍 地点
广东省第二人民医院民航院区
(原民航广州医院、广州白云国际机场急救中心)
广州市机场路290号2号楼四楼，
电梯口右手-中医诊室

就诊流程指引

现场挂号：可到挂号处，挂号“杨烺”医生（中医二羊的本名）

网上预约挂号：
识别二维码关注后

👉 医院服务 👉 我要挂号

👉 民航院区 👉 康复科

👉 杨烺



主攻以经方结合针灸、艾灸等传统古中医方法治疗各类疑难杂病及慢性病。擅长颈肩腰腿痛等痛症以及感冒发热、咳嗽和头痛等外感病，以及失眠，面瘫，中风等神经系统疾病和慢性胃炎、胃痛及便秘等消化系统病症。中医体质辨识和亚健康调养。

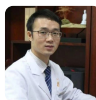
具体地点

广东省第二人民医院民航院区（原民航广州医院、广州白云国际机场急救中心）
广州市机场路290号2号楼四楼，电梯口右手-2号诊室

就诊指引流程：

周一至周五常规门诊，不需要网上预约，具体可到挂号处，挂号“杨烺”医生（中医二羊的

本名)



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

 喜欢作者

医案分享：中医的道与术 68 # 伤寒论学习、应用、体会 8

医案分享：中医的道与术 · 目录

〈 上一篇

中医二羊：胸闷气短胸痹典型经方案一则

下一篇〉

中医二羊复盘四个典型案例：停经、胸痛，
还有一个脑瘤